

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Για το πολυσυζητημένο και ακανθώδες θέμα της διακομιδής ενός διασωληνωμένου ή βαρέως πάσχοντος ασθενούς, από ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία ή από ειδικευόμενους ιατρούς τμημάτων ή κλινικών, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) σε συνεδρίασή του το 2012 είχε γνωμοδοτήσει ανάλογα και ίσχυαν οι αποφάσεις του - έστω και με ορισμένες παρεκκλίσεις στα πραχθέντα - μέχρι προσφάτως· ενώ πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ΦΕΚ Α΄ 208/05.11.2021, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Οι διανοσοκομειακές διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών θα πραγματοποιούνται από ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας ή ειδικευόμενους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει έξι (6) μήνες ειδικότητας.
2. Για την πραγματοποίηση των διακομιδών των διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών καταρτίζεται μηνιαίως λίστα των καθημερινώς εφημερευόντων ιατρών ανά νοσοκομείο, με ευθύνη του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε νοσοκομείου. Οι ιατροί αυτοί εφημερεύουν με εφημερία ετοιμότητας, και εφόσον πραγματοποιήσουν διακομιδή, η εφημερία ετοιμότητας μετατρέπεται σε ενεργή εφημερία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με τη γνώμη του ΚΕΣΥ, δύνανται να ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη διανοσοκομειακή διακομιδή διασωληνωμένων ή βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Η διακομιδή ενός ασθενούς και ειδικά του βαρέως πάσχοντος ή του διασωληνωμένου, εμφανίζει αρκετές προκλήσεις, ιδιαιτερότητες και ενίοτε έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Οι ακραίες μεταβολές της ταχύτητας του ασθενοφόρου, η θερμοκρασία της καμπίνας, η απόσταση και ο χρόνος μέχρι το νοσοκομείο, ο ελλιπής εξοπλισμός του ασθενοφόρου ή του ιατρικού σάκου, η έλλειψη γνώσεων, εκπαίδευσης και εμπειρίας του συνοδού ιατρού και των διασωστών-συνοδών, η ελλιπής αντιμετώπιση και προετοιμασία του ασθενούς πριν τη διακομιδή, είναι θεμελιώδη ζητήματα που αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα και εν τη γενέσει τους μπορεί να αποβούν μοιραία, άμεσα ή μακροπρόθεσμα στην πορεία του ασθενούς.

Θεωρείται θέσφατον στην Επείγουσα Ιατρική ότι ο ασθενής ή τραυματίας πρέπει να διακομίζεται πάντοτε σταθεροποιημένος και η οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση (*φλεβική γραμμή, σωλήνας Levin, καθετήρας Foley, διασωλήνωση, κ.ά.*) που πιστεύεται ότι πιθανώς να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής, πρέπει να πραγματοποιηθεί, εφόσον είναι εφικτό, προ της διακομιδής σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον (ΚΥ, ΤΕΠ, κλινική).

Σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διακομιδή, είναι:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Υποτασικό ή υπερτασικό συμβάν. | • Απόφραξη αεραγωγού. |
| • Καρδιακές αρρυθμίες. | • Μετακίνηση τραχειοσωλήνα. |
| • Καρδιακή ανακοπή. | • Υποθερμία. |
| • Διαταραχές αερίων αίματος. | • Απώλεια ενδοφλεβίων γραμμών. |
| • Εμετός και εισρόφιση. | • Πτώση από το φορείο - τραυματισμός. |

Άρα, σαν «επιμύθιο», πρέπει να θυμόμαστε ότι η διακομιδή του ασθενούς και ιδίως του βαρέως πάσχοντος, δεν αποτελεί απλώς μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο, που λόγω συνθηκών πρέπει αναγκαστικά να επιτελεστεί, αλλά πρόκειται για μία άκρως απαιτητική ιατρονοσηλευτική πράξη, σε περιορισμένο χώρο, με περιορισμένα μέσα και εν κινήσει!

Ο ιατρός και το πλήρωμα του ασθενοφόρου, πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έτοιμοι για μια τόσο απαιτητική διαδικασία, όπως η μεταφορά του βαρέως πάσχοντος.

Σε καμία περίπτωση, η Ιατρική Δεοντολογία αλλά και η κοινή λογική, δεν επιτρέπει τη διακομιδή ενός βαρέως πάσχοντος ή διασωληνωμένου ασθενούς από έναν άπειρο, ανειδίκευτο ή παντελώς ανεκπαίδευτο για αυτόν το σκοπό ιατρό και μάλιστα έναν νέο (αγροτικό) ιατρό που υπηρετεί (ή εφημερεύει) στο ΚΥ ή στο νοσοκομείο στο πλαίσιο εκπλήρωσης θητείας υπηρεσίας υπαίθρου.